

Les péritonites

Dr N. BOULEKROUNE

Plan du cours

- ✚ **Part 01 :** - Objectifs pédagogiques
Généralités - Définition et classification
- Bases anatomiques
- Physiopathologie

- ✚ **Part 02 :** - Signes fonctionnels
Etude sémiologique - Signes généraux
- Signes physiques

- ✚ **Part 03 :** - Radiologie
Examens - Biologie
Complémentaires

- ✚ **Part 04 :** - Péritonite appendiculaire
Etiologies - Péritonite par perforation d'ulcère gastrique ou duodénal
- Autres étiologies

- ✚ **Part 05 :**
Evolution

- ✚ **Part 06 :** - Points à retenir
Conclusion - Références bibliographiques

Objectifs pédagogiques



1. Définir la péritonite aigue (PA).
2. Décrire les caractéristiques sémiologiques d'une PA.
3. Citez les causes de la PA.

I. Généralités

A) Définition :

- ✚ Les péritonites aiguës (PA) se définissent comme une inflammation aigue généralisée ou localisée de la séreuse péritonéale, le plus souvent d'origine infectieuse.
- ✚ Il s'agit d'une urgence chirurgicale fréquente et grave pouvant mettre en jeu le pronostic vital du patient en l'absence de prise en charge rapide et adaptée.
- ✚ Le diagnostic est basé sur l'examen clinique, qui permet de rechercher des signes d'irritation péritonéale.
- ✚ Les étiologies sont multiples et le diagnostic étiologique est important à établir en se référant à l'anamnèse, à l'examen clinique et aux examens complémentaires.

B) Bases anatomiques :

- ✚ Le péritoine est une membrane séreuse qui tapisse entièrement les parois de la cavité abdomino-pelvienne.
 - ✚ Il est constitué de deux feuillets en continuité l'un avec l'autre :
 - Le feuillet pariétal : qui tapisse la face profonde de la cavité abdomino-pelvienne.
 - Le feuillet viscéral : qui tapisse la face superficielle des différents viscères abdominaux.
- ➡ Ces deux feuillets délimitent la cavité péritonéale : un espace virtuel.



C) Classification :

C-1) Selon le mode de contamination :

- Il existe plusieurs classifications des péritonites infectieuses.
- La classification de **Hambourg** est la plus utilisée. Elle les sépare en trois classes selon l'origine de l'infection :

1. Les péritonites bactériennes primitives :

- ✚ Ce sont des PA rares qui surviennent en l'absence de foyer infectieux primaire intra-abdominal ou de solution de continuité du tube digestif.
- ✚ La contamination péritonéale se fait :
 - souvent par voie hématogène au cours d'une septicémie,
 - plus rarement par translocation bactérienne.
- ✚ Il s'agit d'infections mono-bactériennes (à un seul germe).
- ✚ L'étiologie la plus fréquente est l'infection à E. coli du liquide d'ascite chez les patients cirrhotiques.
- ✚ Les autres tableaux rencontrés sont :
 - péritonite primitive à pneumocoque compliquant ou révélant un syndrome néphrotique
 - infection à staphylocoque par l'intermédiaire du cathéter chez les patients en dialyse péritonéale
 - plus rarement : péritonite primitive tuberculeuse.
- ✚ Leur traitement est médical.

2. Les péritonites bactériennes secondaires :

- ✚ Elles sont les plus fréquentes et les plus graves.
- ✚ Elles sont secondaires :
 - à la perforation d'un segment digestif ou biliaire,
 - ou à la diffusion d'une infection intra-abdominale.
- ✚ Ce sont des infections polymicrobiennes liées à la flore intestinale pathogène.
- ✚ La cause la plus fréquente de péritonites secondaire est l'appendicite compliquée, suivie des perforations d'ulcères gastroduodénaux diagnostiquées tardivement, des sigmoïdites et d'autres infections digestives ou gynécologiques. Elles peuvent également être consécutives à un acte opératoire abdominal.
- ✚ Leur traitement est à la fois médical et chirurgical.

3. Les péritonites tertiaires :

- ✚ Elles correspondent à des infections abdominales persistantes malgré un traitement initialement bien conduit (antibiothérapie adaptée et éradication du foyer primitif abdominal par une ou plusieurs interventions).
- ✚ La cavité abdominale est alors surinfectée par des micro-organismes peu virulents mais devenus résistants ou par des levures.
- ✚ Ces péritonites sont souvent associées à un syndrome de défaillance multiviscérale.

C-2) Selon la diffusion de la péritonite :

- Les péritonites généralisées à toute la cavité péritonéale.
- Les péritonites localisées.
- ✚ Parmi les péritonites localisées les plus fréquentes :
 - Les abcès sous phréniques qui peuvent succéder à un abcès du foie ou de la rate ou compliquer une intervention chirurgicale portant le plus souvent sur un viscère sus-mésocolique.
 - Les abcès du Douglas qui peuvent succéder à une suppuration annexielle par exemple ou compliquer un geste chirurgical tel qu'une appendicectomie.

D) Physiopathologie :

D-1) Les moyens de défense du péritoine :

- ✚ Le péritoine se comporte comme une membrane semi perméable qui réalise une surface d'échange très étendue.
- ✚ Il présente d'importantes capacités de défense :
 - transformation phagocytaire des cellules péritonéales,
 - exsudat diluant les germes ayant une action bactérienne,
 - capacités adhérentielles obturant les brèches intestinales, cloisonnant le péritoine,
 - réaction fibrinaire, source d'adhérences.

D-2) Les différents types de péritonites : selon la nature de l'agression péritonéale, on distingue deux types de péritonites :

- ✚ Les péritonites chimiques : le type en est la perforation digestive haute, gastrique ou duodénale, par laquelle s'écoule un liquide caustique acide ou alcalin (acidité gastrique, suc pancréatique, bile et sels biliaires) et provoquant une véritable brûlure chimique interne.
- ✚ Les péritonites bactériennes : le type en est la perforation digestive moyenne ou basse, iléale ou colique. A travers la perforation s'écoule du liquide fécal ou iléal qui contenant une forte concentration de germes aérobies et anaérobies.

II. Etude sémiologique : les signes communs de la péritonite aiguë

A) Signes fonctionnels :

- 1) La douleur abdominale : elle constitue le maître symptôme.
 - ✚ A début variable, brutale, violente ou plus progressive.
 - ✚ Elle est souvent permanente, avec des paroxysmes.
 - ✚ Elle peut être diffuse d'emblée ou débiter de façon localisée à un quadrant de l'abdomen et pour ensuite se propager à tout l'abdomen.
 - ✚ Son siège initial permet d'orienter l'étiologie.
 - ✚ Elle s'aggrave lors de toutes les manœuvres augmentant la pression intra-péritonéale comme les mouvements, la toux, les éternuements, les efforts de défécation ou la palpation.
- 2) Les vomissements : sont inconstants, précoces et bilieux.
- 3) Des troubles du transit :
 - ✚ Arrêt des matières et des gaz en rapport avec l'iléus paralytique.
 - ✚ Diarrhées : pouvant remplacer l'arrêt des matières et des gaz.

B) Signes généraux :

- ✚ Etat général : rapidement altéré, le malade est figé, il présente un faciès tiré, des lèvres sèches, des yeux excavés et un pincement des ailes du nez. C'est le **faciès péritonéal** classique.

- ✚ La fièvre : est soit absente, soit présente à une température autour de 39/40°. Parfois, elle est remplacée par une hypothermie, signe de mauvais pronostic.

C) Signes physiques :

- ✚ L'examen abdominal est le temps fondamental du diagnostic.
- ✚ L'examen doit être réalisé sur un patient dévêtu, en décubitus dorsal sur un plan dur. Les bras sont tendus le long du corps, les cuisses sont en légère abduction et les jambes sont en semi-flexion.

C-1) L'inspection :

- ✚ L'abdomen est immobile, ne respire pas.
- ✚ Les muscles droits sont contractés et saillants sous la peau visibles surtout chez les personnes maigres.

C-2) La palpation :

- ✚ Elle est pratiquée avec douceur, les mains réchauffées et posées bien à plat sur l'abdomen.
- ✚ Elle permet de mettre en évidence :
 - La contracture abdominale, qui se caractérise par une rigidité réflexe, involontaire, permanente, invincible et douloureuse de la paroi abdominale réalisant un véritable « ventre de bois ».
 - Parfois, la contracture est remplacée par une défense généralisée qui est une contraction musculaire réflexe déclenchée par la douleur et la palpation.
- ✚ Néanmoins, la défense ou la contracture sont inconstantes, surtout chez les patients comateux, âgés, dénutris ou sous corticoïdes, chez qui la perception de la douleur peut être altérée.
- ✚ Le toucher rectal : provoque une vive douleur au niveau du cul de sac de Douglas. Il n'est toutefois plus réalisé en pratique courante.

C-3) La percussion : permet de rechercher un tympanisme pré-hépatique, signe d'un pneumopéritoine.

C-4) L'examen clinique permet également à rechercher des signes généraux de gravité, comme un sepsis sévère, une oligo-anurie, un état de choc ou une défaillance d'organe.

III. Examens paracliniques

Urgence chirurgicale : aucun examen ne doit retarder le diagnostic et la mise en œuvre du traitement.

A) Radiologie :

A-1) Le cliché d'abdomen sans préparation (centré sur les coupes et idéalement réalisé debout), peut révéler :

- ✚ Un pneumopéritoine, signe de perforation d'un organe creux sous la forme d'une hyperclarté sous-diaphragmatique uni- ou bilatérale.
- ✚ Iléus réflexe (dilatation gazeuse du grêle.)

A-2) Echographie abdomino-pelvienne : peut mettre en évidence des épanchements péritonéaux et des abcès intra-abdominaux.

A-3) Scanner abdomino-pelvien :

- ✚ Il est utile :
 - Non seulement pour confirmer le diagnostic en cas d'examen physique douteux ou difficile (sujets obèses, contexte postopératoire précoce, polytraumatisé),
 - Mais aussi pour orienter vers la cause de l'infection et guide le geste chirurgical.
- ✚ Il met en évidence des signes non spécifiques de péritonite et leur localisation (épanchement, épaissements des feuillets péritonéaux), un pneumopéritoine même minime, une infiltration de la graisse périviscérale et/ou un épaissement digestif.

B) Biologie :

- Ils n'ont aucune valeur diagnostique mais permettent :
- ✚ D'évaluer la gravité de la péritonite :
 - Créatinine et urée : insuffisance rénale aiguë fréquente liée au sepsis ou à la déshydratation,
 - Gazométrie : acidose métabolique.
- ✚ D'évaluer son retentissement infectieux :
 - numération formule sanguine (NFS) : hyperleucocytose,
 - Elévation de la CRP et de la procalcitonine.
- ✚ Et d'aider à la prise en charge anesthésique (bilan préopératoire complet) :
 - Bilan d'hémostase : TP, TCA,
 - Bilan pré-transfusionnel : groupage sanguin, rhésus, recherche d'agglutinines irrégulières).
- Les prélèvements bactériologiques (hémocultures, examen cytobactériologique des urines, ponction d'ascite...) doivent être réalisés le plus tôt possible, de préférence avant l'instauration d'un traitement antibiotique.

IV. Étiologies

A) La péritonite appendiculaire :

- ✚ C'est le diagnostic étiologique le plus fréquent.
- ✚ Elle complique l'évolution d'une appendicite aiguë, mais peut parfois être le tableau inaugural, notamment chez des patients âgés, dénutris ou immunodéprimés.
- ✚ Elle se manifeste par une douleur à point de départ iliaque droite, qui se généralise rapidement à tout l'abdomen en l'absence de prise en charge précoce.
- ✚ L'examen révèle une défense généralisée, avec un point de défense maximal au niveau de la fosse iliaque droite, ainsi qu'une fièvre autour de 39°C.
- ✚ Les examens biologiques révèlent un syndrome inflammatoire caractérisé par une hyperleucocytose et une augmentation de la CRP.
- ✚ Le diagnostic est confirmé par l'imagerie, de préférence par un scanner A/P.

B) Péritonites par perforation d'ulcère gastroduodénal :

- ✚ L'interrogatoire révèle des antécédents d'ulcère ou de syndrome ulcéreux typique, ainsi que des facteurs favorisants tels que la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, le tabagisme ou un jeûne prolongé.
- ✚ La douleur initiale est brutale, ressentie comme un coup de poignard, et de siège dans la région épigastrique. Elle se généralise rapidement à tout l'abdomen.
- ✚ L'examen révèle une défense ou une contracture abdominale, avec un état général relativement conservé et une absence de fièvre au début.
- ✚ Le diagnostic est confirmé par l'imagerie :
 - Sur le cliché d'ASP, la présence d'un pneumopéritoine suffit à confirmer le diagnostic et à poser l'indication opératoire, mais son absence ne permet pas d'éliminer la perforation, car elle peut être colmatée par un organe voisin.
 - Le scanner, plus sensible, met le plus souvent en évidence des signes indirects de perforation, tels qu'un pneumopéritoine souvent volumineux et un épanchement dont la localisation est sus-mésocolique. Il permet parfois de préciser le lieu de la perforation.

C) Autres étiologies :

1. Péritonites par perforation du grêle (jéuno-iléale).
2. Péritonites par perforation colique (néoplasiques, diverticulaires, colites aiguës.....).
3. Péritonites biliaires.
4. Péritonites d'origine hépatique.
5. Péritonite génitale.
6. Les péritonites urinaires.
7. les péritonites pancréatiques.
8. Les péritonites post-opératoires.

9. Les péritonites primitives.

IV. Evolution :

Une péritonite non traitée évolue rapidement de manière dramatique. Elle entraîne rapidement le décès par sepsis sévère ou syndrome de défaillance poly-viscérale.

V. Points à retenir :

- + La péritonite aigue est une urgence fréquente et grave mettant en jeu le pronostic vital.
- + Le diagnostic de péritonite est clinique : syndrome péritonéal (contracture abdominale ++).
- + Il est primordial de poser le diagnostic d'une PA à temps et d'entamer rapidement les mesures thérapeutiques afin d'améliorer le pronostic.
- + Certaines formes cliniques sont de diagnostic difficile et nécessitent le recours à des examens complémentaires, notamment le scanner abdominal.
- + Les deux causes les plus fréquentes sont : l'ulcère perforé et l'appendicite compliquée.